

Def. Auditivo (leitura labial)

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS

JOANA D ARC LUCINDO EUZEBIO

IDADE: 68 PESO: 98 ALTURA: 156 PROFISSÃO: Dolar (Industria)

SINTOMAS: refluxo / ansiedade

QUEIXAS: Irritabilidade / Ansiedade /

MEDICAMENTOS:

HAS / celest. / DM /

MÉDICO: Dra. Marialva

MARCAPASSO: () S ☒ N / COMPANHEIRO USA MARCAPASSO: () S ☒ N

EXERCÍCIO FÍSICO: não faz

HORÁRIO DAS REFEIÇÕES: CAFÉ:

ALMOÇO:

LANCHE:

JANTAR:

HORA QUE DORME: 21:30

HORA QUE ACORDA: 4:30.

COCHILHO: () S ☒ N

DORME ACOMPANHADO: () S ☒ N () EVENTUALMENTE

TEM FILHOS: ☒ S () N

DORMEM NO QUARTO: () S ☒ N

PET NO QUARTO: () S ☒ N

BEBIDA ALCOÓLICA: () S () X NA SEMANA ☒ N

FUMO: () S () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal

BANHEIRO/NOITE: 0X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL:

CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: não

MALLAMPATI:

IAH: 21.4

SPO2: 81%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS: Lesão nos joelhos (elet.)

Coluna lombar torácica

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA

Másc. úsp. tec. small.

HIPERVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:

COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA

(S) ORTOPÉDICA

(S) NEUROLÓGICA

() OUTROS:

POLISSONOGRAFIA COM CPAP: () S ☒ N

SPO2 C/ CPAP: -

PRESSÃO NO EXAME: -

17/10 Avaliação e locação (falar c/ a filha no whats). fua

24/10 Dificuldade p/ se adaptar devido a insegurança

24 co. / acorda muitas vezes ainda.

Abre a boca

Relata melhora da disposição.

04/11 P= 6,6 media

Relato estar espirrando

24 IAH= 14 elw

mais vezes.

Fuga= 8,1 lpm.

Melhora da ansiedade e da fadiga mpm.

15/11/24 P= 6,6 cmH2O (fixa)

IAH= 1,8 elw

ufue sentir confortável c/ CPAP agora

m up= 8h30 min

fuga= 21l/min.

Silva

02/12
2024

P = 6,6 cmH₂O
IAH = 1,1 elh
m uso = 6h40 min
fuga =

Sente Bem. (vai viajar jan/fev, por isso agendo retorno em dez)

Silvia

16/12
2024

P = 6,6 cmH₂O
IAH = 1,3
m uso = 6h18
fuga = 20l/min

→ passou mal d dor no peito há uns 15 dias
refe começo aos esforços

→ está fazendo exames do cardiologista
MMII edemacizados.

→ se sente mais calma depois do CPAP.

Silvia

19/02
25

P = 6,6 cmH₂O
IAH = 1,8 efer
fuga = 5,2
m. de uso: 6h40'

- Bem adapt., porém ainda dormindo
- Superf.
- Boca seca.
- Relata estar bebendo água

Silvia

26/05
2025

P = 6,6 cmH₂O
IAH = 1,4 elh
m uso = 7h10 min
fuga = 22l/min

último dia fica d CPAP mas n dorme
relata "coceira" no pé à noite - já
passou no vascular.
vai no stomi no - faz relatório

Silvia

Receituário

SAO JOSE DOS CAMPOS, 24 de setembro de 2024.

Sra. Joana Darc Lucindo Euzebio

Prescrição:

Solicito

**CPAP auto
rampa automática
titulação domiciliar**

Sugerido mascara nasal

Maniah Prata-Soldi Passos Taube (CRM 134230)

Nome: JOANA DARC LUCINDO EUZEBIO

Data de Nascimento: 13-11-1956

IMC: 39,06

Sexo: Feminino

Data do exame: 25-07-2024

Peso: 100 kg

Altura: 1,60 m

Médico: DRA. MARIAH PRATA SOLDI

PASSOS

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 25-07-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 548,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 95,5 e 93,0 minutos. O tempo total de sono foi de 411,5, eficiência de 75,0% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,6%; estágio N2: 61,1%; estágio N3: 15,1%; sono REM: 22,2%. O índice de despertares foi de 10,9/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 21,4/hora, sendo elas 11 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 126 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e mínima de 81%, permanecendo 56,0% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 71 - 97 bpm e NREM de 67 - 103 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (4), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 21,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=81%);
5. latência para o sono aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. aumento do número de movimentos periódicos de membros inferiores (23,5/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

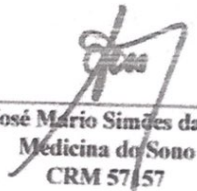
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado associado a distúrbio de movimento.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mário Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57